

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

Solicitante: Dra. Danúbia Michetti Silva – CRM DF 19710.

Avaliadora: Dra. Flávia Martins da Silva - CRP 01/9526

Interessado: Luiz Edilson Marcelino Barros

Dados de identificação:

Nome do paciente: Luiz Edilson Marcelino Barros

Data de nascimento: 19/08/1950 Idade: 65 anos

Sexo: Masculino

Naturalidade: Acopiara - CE

Escolaridade: Nível Superior Completo com Pós-Graduação

Lateralidade: Destra

Profissão: Professor

Telefone: 3361 2399

Endereço: AOS 5 bloco C apto 210 – Octogonal

Cidade: Brasília

Estado: DF

Motivo:

Avaliação neuropsicológica para avaliar o comportamento, as funções corticais superiores e o estado afetivo-emocional da paciente.

Histórico:

Diagnósticos prévios: Depressão, HAS

Medicações: Escitalopram

HD: G 30.9

Exames realizados:



FLÁVIA MARTINS

Psicologia & Neuropsicologia

Anamnese:

Luiz Edilson Marcelino Barros, homem, 65 anos de idade, casado, tem quatro filhos e cinco netos. Atualmente ele reside na Octogonal com a esposa e uma filha. Ele é católico e ministra aulas em cursos para concurso público em outro Estado (Palmas – TO).

O paciente compareceu a entrevista inicial acompanhado pelo filho, Petrus. O Sr. Edilson relatou que no mês de novembro do ano de 2014 ele teve uma crise de estresse a qual lhe provocou uma série de esquecimentos e fez toda família preocupar-se. Ele foi avaliado clinicamente pela médica geriatra que solicitou exame de ressonância magnética e a avaliação neuropsicológica.

Sr. Edilson disse que até o final do ano de 2014 era uma pessoa muito ocupada e envolvida em muitas atividades (trabalho, movimento da Igreja) e viaja muito. Ele e a esposa eram responsáveis por escreverem textos para a Igreja e ele começou a cometer erros graves ao redigir. Em janeiro de 2015 ele referiu que tirou férias, viajou e sentiu-se melhor. A medicação o fez sentir-se melhor.

O paciente referiu que a esposa e os filhos estavam o achando frequentemente esquecido. Mas, o filho complementou dizendo que acha que o pai sempre teve déficit de atenção e que era avoado (sic). Além disso, Sr. Edilson disse que começou a ficar nervoso, com vontade de ser agressivo, apático e isolou-se socialmente. Ele disse que em situações de urgência tem mais dificuldades de processar os estímulos e de tomar uma decisão.

Sr. Edilson referiu que escuta pior no ouvido esquerdo e tem déficit visual. Ele faz uso de óculos de grau. O paciente tem histórico clínico de hipertensão arterial e negou outras doenças. Na família existem casos de doença de Alzheimer (pai, mãe e irmã).

O paciente referiu que sempre está pronto para ajudar as pessoas ao seu redor (esposa, filhos, amigos, sogra) e que tende a resolver os problemas dele e das outras pessoas, pois tem dificuldades para dizer não. Ele disse que tem rotinas pré-estabelecidas e que tinha dificuldades para quebra-las.

A esposa do paciente compareceu posteriormente em uma das sessões de avaliação neuropsicológica e relatou alguns episódios de desorganização mental do marido (perder o carro, esquecer compromissos), os quais a deixaram muito preocupada. Ela tem procurado cobrar menos do marido desde a crise de estresse que Sr. Edilson teve.

Método:

Realizou-se a avaliação neuropsicológica para avaliar as competências e dificuldades das funções psicológicas superiores (atenção, percepção visual, memória, habilidades aritméticas, linguagem e funções executivas) ao longo de dez sessões. Os principais instrumentos utilizados foram: MEEM, NEUPSILIN, WAIS-III, RAVLT, *Test Stroop Victoria*, Teste dos cinco pontos, Figura Complexa de Rey, FAS e teste Trilhas. Para avaliação afetiva-emocional aplicou-se o teste projetivo Rorschach. A análise dos dados foi fundamentada na compreensão sistêmica e dinâmica das funções nervosas superiores de acordo com Alexander R. Luria.

O paciente mostrou-se vigil e colaborativo ao longo da testagem.

Resultados:

Tabela 1 – Teste de rastreio: Mini Exame do Estado Mental

MEEM		
Subtestes	Nota Z	Interpretação
Orientação temporal	0,5	Média
Orientação espacial	0,5	Média
Memória recente	0,1	Média
Memória tardia	-1,2	Média inferior
Atenção e cálculo	0,2	Média
Nomeação	0,1	Média
Repetição	0,3	Média
Compreensão	-2,3	Deficitário
Leitura	0,4	Média
Escrita	0,6	Média
Visuoespacial	0,7	Média superior
TOTAL	-1,1	Média inferior

O resultado do teste de rastreio sugeriu quadro de confusão mental que necessitou ser melhor investigado por meio de avaliação neuropsicológica mais específica e detalhada.



FLÁVIA MARTINS

Psicologia & Neuropsicologia

Tabela 2 – Subtestes, pontos ponderados (Z) e interpretação dos resultados por meio da Bateria de Avaliação Neuropsicológica Breve – NEUPSILIN.

Subtestes	Z	Interpretação
1. Orientação têmporo-espacial	0,6	média
1.1. Tempo	0,6	média
1.2. Espaço	-	média
2. Atenção	-1,5	média inferior
2.1. Contagem inversa	-3,3	deficitário
Tempo	-2,9	deficitário
2.2.Repetição de sequência de dígitos	2,1	superior
3. Percepção:	-3,2	deficitário
3.1. Verificação de linhas	-3,3	deficitário
3.2. Heminegligência visual	-	média
3.3. Percepção de faces	-1,7	limítrofe
3.4. Reconhecimento de faces	0,3	média
4. Memória	0,0	média
4.1. Memória de trabalho	0,8	média superior
A) Ordenamento ascendente	0,9	média superior
Maior sequência repetida	0,9	média superior
B) <i>Span</i> auditivo de palavras	0,6	média
Maior conjunto de palavras	0,4	média
4.2. Memória verbal episódico-semântica	-0,9	média inferior
A) Evocação imediata	0,3	média
B) Evocação tardia	-1,0	média inferior
C) Reconhecimento	-1,1	média inferior
4.3. Memória semântica de longo prazo	0,2	média
4.4. Memória visual de curto prazo	-1,4	limítrofe
4.5. Memória prospectiva	0,8	média superior
5. Habilidades aritméticas	0,4	média
6. Linguagem	-0,9	média inferior
6.1. Linguagem oral	-2,4	deficitário
A) nomeação	-	média



B) repetição	-4,0	deficitário
C) linguagem automática	-	média
D) compreensão	0,4	média
E) Processamento de inferências	-1,4	limítrofe
6.2. Linguagem escrita	0,3	média
A) leitura em voz alta	0,3	média
B) compreensão escrita	0,4	média
C) escrita espontânea	0,3	média
D) escrita copiada	0,3	média
E) escrita ditada	0,0	média
7. Praxias		
7.1. Ideomotora	-	média
7.2. Construtiva	-	-
7.3. Reflexiva	-0,1	média
8. Funções executivas		
8.1. Resolução de problemas	0,4	média
8.2. Fluência verbal	2,7	superior
A) número de vocábulos	2,9	superior
B) perseverações	-	média
9. tempo de aplicação	2,2	superior

Na Tabela 1, podem ser observados os escores padronizados (Nota Z) calculados a partir da comparação com os dados normativos e a interpretação em cada subteste do NEUPSILIN. Observa-se que de forma geral, o desempenho do Sr. Edilson nos subtestes foi semelhante e/ou acima da média em relação ao seu grupo normativo (idosos, com mais de nove anos de estudo formal) – orientação têmporo-espacial, habilidades aritméticas, linguagem escrita, praxias e resolução de problemas.

Verificou-se que o paciente teve destaque *superior* no desempenho do subteste de repetição de sequência de dígitos, fluência verbal e no tempo total de aplicação da bateria. O paciente obteve classificação *média superior* nos subtestes de memória operacional e memória prospectiva. E o paciente obteve desempenho *inferior à média* nos subtestes de atenção, memória semântica tardia e reconhecimento. Sr. Edilson apresentou déficit de desempenho nos



FLÁVIA MARTINS

Psicologia & Neuropsicologia

subtestes de contagem inversa, percepção visual, memória visual de curto prazo, linguagem oral (repetição e processamento de inferências).

Observou-se que o paciente apresenta sinais de comprometimento das vias sensório-perceptuais (visuais e auditivas). Os déficits visuais parecem interferir em atividade de percepção de faces, desempenho visuomotor e possivelmente em memória visual, o que pode relacionar-se com o sistema visual (área sensorial e área associativa visual – lobo occipital) e idade do paciente. E, os déficits auditivos podem prejudicar atividades de linguagem oral. Além disso, Sr. Edilson demonstrou dificuldades no controle mental, na atividade de evocação, no reconhecimento de palavras e no processamento de inferências, o que pode relacionar-se com alterações no lobo frontal esquerdo e no lobo têmporo-medial.

A alta escolaridade do paciente (nível superior completo com pós-graduação) pode relacionar-se com o bom desempenho que o paciente teve em outras capacidades cognitivas deste teste e como um fator de proteção das funções neuropsicológicas.

Uma investigação mais detalhada da memória, atenção, linguagem e funções executivas foi realizada, visto as queixas apresentadas pelo paciente e sua esposa.

Tabela 3: Avaliação da memória e processos de aprendizagem por meio do teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey (Malloy-Diniz, Cruz, Torres & Cosenza, 2000).

RAVLT		
Item	Nota Z	Interpretação
A1	-0,2	Média
A2	-0,9	média inferior
A3	0,8	média superior
A4	-1,1	média inferior
A5	-0,5	Média
A6	-1,7	Limítrofe
A7	-1,7	Limítrofe
TOTAL	-0,5	Média
B1	-0,4	Média
ITR	-2,2	deficitário
ITP	-0,4	Média
ESQUECIMENTO	0,2	Média
RECONHECIMENTO	1,1	média superior



FLÁVIA MARTINS

Psicologia & Neuropsicologia

Análise e interpretação do resultado

O paciente apresentou capacidade para o aprendizado dentro da faixa normativa. Verificou-se que o paciente apresentou tendência para a interferência retroativa, ou seja, uma segunda aprendizagem pode interferir na recordação da primeira aprendizagem. Ele demonstrou melhora no desempenho da tarefa por meio de atividade de reconhecimento.

Tabela 4: Avaliação da memória e processos de aprendizagem por meio do teste Figuras Complexas de Rey

Figura Complexa de Rey	Pontuação	Percentil	Interpretação
Cópia	33	70	Superior
Tempo	3	30	Normal
Memória	6	10	Inferior à média
Tempo	2	30	Normal

Análise e interpretação do resultado

O resultado da atividade de cópia sugeriu que o paciente teve boa capacidade de percepção visual e cópia precisa e bem estruturada. No entanto, o paciente pode ter um significativo prejuízo na capacidade de memória imediata com tendência para fazer distorções na forma e alteração nas localizações e omissões de elementos - tempo normal.

Tabela 5: Avaliação Funções executivas e linguagem – Fluência Verbal fonêmica (FAS) e semântica (animais e frutas).

FAZ		
Item	Nota Z	Interpretação
Letra F	3,1	Muito superior
Letra A	1,6	Superior
Letra S	0,3	Média
Total	1,9	Superior
Animais	>13	Média
Frutas	>13	Média



FLÁVIA MARTINS

Psicologia & Neuropsicologia

Análise e interpretação do resultado

No teste de fluência verbal (F.A.S), o paciente apresentou desempenho geral superior, o que demonstrou que o paciente conseguiu sustentar a atenção, planejar, organizar e verificar suas respostas por meio das funções executivas. Além disso, Sr. Edilson demonstrou competência cognitiva para produção e fluência semântica. No entanto, observou-se que o paciente tende a realizar perseverações, isto é, repetições incontroláveis de uma resposta anteriormente correta, mas que se tornou inapropriada por meio desse mecanismo.

Tabela 6: Avaliação Funções executivas – teste dos 5 pontos

Teste 5 pontos			
Item	Pontuação	Nota Z	Interpretação
Desenhos únicos	35	1,7	Superior
Desenhos repetidos	3	0,8	Média superior

Análise e interpretação do resultado

O paciente demonstrou uma boa habilidade do hemisfério direito por meio da atividade de fluência não verbal. O desempenho visuoconstrutivo e motor estão bem acima da média, porém, o paciente apresentou perseveração na atividade.

Tabela 7: Avaliação Funções executivas – Teste Trilhas

Teste Trilhas			
Trilhas	Percentil		Interpretação
Forma A	25	90	Média superior
Forma B	54	90	Média superior

Análise e interpretação do resultado

O paciente apresentou boa acuidade visual, boa coordenação motora, rapidez no processamento da informação, atenção alternada, flexibilidade cognitiva, resistência à interferência e rapidez na tomada de decisão.



FLÁVIA MARTINS

Psicologia & Neuropsicologia

Tabela 8: Avaliação da atenção – teste *Stroop*

Stroop	Tempo (segundos)	Nota Z	Interpretação
C1 atenção concentrada	15	-1,3	Média inferior
C2 atenção dividida	21	-1,4	Limítrofe
C3 atenção sustentada	41	-1,2	Média inferior

Análise e interpretação do resultado

Os resultados da avaliação da atenção, por meio do teste *Stroop*, sugeriram déficit em atenção concentrada, sustentada e seletiva. Sendo assim, o paciente pode ter sofrido interferências no processo de atenção e no controle inibitório durante a execução das atividades cognitivas.

Tabela 9: Resultados e interpretação do teste da Escala Wechsler de Inteligência para adultos

SUBTESTES WAIS-III	Subtestes Compreensão Verbal			
			ESCORES	
	Subtestes	Pontos Brutos	Pontos Ponderados	Resultado
	Informação: avalia memória de longo prazo; mede a capacidade de adquirir, reter e recuperar conhecimentos.	20	15	Superior
	Semelhanças: Avalia a capacidade de estabelecer conceitos e fazer generalizações	25	14	Superior
	Compreensão: mede raciocínio verbal e conceituação, expressão verbal, entendimento de princípios gerais e vivência social. Avalia capacidade para julgamento e maturidade.	27	14	Superior
	Vocabulário: mede conhecimento de palavras, formação de conceitos verbais, nível de conhecimento, habilidade para o aprendizado, memória de longo prazo e desenvolvimento linguístico.	48	13	Média superior
	Subtestes de Organização Perceptual			
			ESCORES	
	Subtestes	Pontos Brutos	Pontos Ponderados	Resultado
	Cubos: Habilidades visuo- espaciais e praxia de construção. Análise e Síntese. Percepção visual, processamento simultâneo.	32	14	Superior
	Raciocínio Matricial: inteligência fluída, habilidade intelectual. Processamento visual.	20	19	Muito superior
	Completar Figuras: percepção visual e organização, reconhecimento visual de detalhes e concentração.	17	18	Muito superior
	Subtestes Memória Operacional			
			ESCORES	
	Subtestes	Pontos Brutos	Pontos Ponderados	Resultado
	Dígitos: avalia a Atenção/concentração; Memória auditiva de curto prazo e operacional; sequenciamento.	19	18	Muito superior
	Sequência de Números e Letras: sequenciamento, agilidade mental, atenção, memória auditiva de curto prazo, velocidade de processamento.	06	11	Média
	Aritmética: raciocínio numérico; Atenção/concentração; Memória de curto e longo prazo e operacional. Agilidade mental.	10	11	Média
	Subtestes Velocidade de Processamento			
			ESCORES	
	Subtestes	Pontos Brutos	Pontos Ponderados	Resultado
	Códigos: velocidade de processamento; memória de curto prazo, coordenação visual e motora; percepção visual; motivação; atenção; flexibilidade.	60	17	Muito superior
	Procurar Símbolos: velocidade de processamento; memória visual de curto prazo; coordenação visual e motora; flexibilidade cognitiva; discriminação visual e concentração.	23	15	Superior



Escala de QI e índices fatoriais – WISC-III			
	Soma Pontos Ponderados	QI/ índices	Resultado
QI Total	163	130	Superior
QI Verbal	85	124	Superior
QI execução	78	134	Superior
ICV (índice de compreensão verbal)	42	122	Superior
IOP (índice de organização perceptual)	51	140	Superior
IMO (índice de memória operacional)	30	100	Média
IVP (índice de velocidade de processamento)	32	133	Superior

Análise e interpretação do resultado da avaliação da inteligência:
O resultado do WAIS-III evidenciou um funcionamento intelectual global classificado como superior (QI 130). O paciente apresentou Quociente de Inteligência Verbal Superior (QIV 124) e Quociente de Inteligência de Execução (QIE 134) em nível superior indicando que ele demonstrou inteligência tanto através de materiais figurativos e concretos não verbais quanto por meio da compreensão e expressão verbal. Sr. Edilson apresentou escore classificado como superior no índice de compreensão verbal (ICV) e no índice de organização perceptual (IOP). No índice de memória operacional (IMO) o paciente demonstrou resultado médio, mas em velocidade de processamento (IVP) foi superior. Os déficits atencionais podem relacionar-se com a queda no índice de memória operacional quando comparado aos demais índices.

Avaliação personalidade pelo teste projetivo Rorschach:

Ideação

Por meio do exame projetivo Rorschach, observou-se que Sr. Edilson pode apresentar aumento do desconforto interno, da sobrecarga interna e da atividade de ideação periférica, o que pode ser proveniente de seus estados de necessidade não satisfeitos. Como consequência o paciente poderia apresentar dificuldades nos processos de atenção/concentração e problemas para conciliar o sono.

Verificou-se que o Sr. Edilson pode adotar um papel passivo nas suas relações interpessoais e ele pode preferir colocar-se como sujeito paciente das ações dos demais e esperar que os outros solucionem seus problemas. Com isso, ele pode evitar responsabilizar-se e assumir as consequências de suas decisões. Não necessariamente ele se comporte apenas como uma pessoa submissa e, algumas vezes, ele pode adotar um posicionamento mais agressivo em suas relações interpessoais.

O paciente demonstrou que tende a buscar refúgio na fantasia para gratificar as suas necessidades e para compensar imaginariamente as frustrações da vida real (propensão ao



FLÁVIA MARTINS

Psicologia & Neuropsicologia

sonho, ao jogo imaginário e ao uso da fantasia). Isso pode ser muito positivo caso ele seja capaz de utilizar criativamente essas atividades, mas pode ser um problema se esse estilo invadir excessivamente seus processos ideativos e se transformar em uma estratégia defensiva para evitar o confronto com as dificuldades cotidianas.

Percebeu-se, também, que o Sr. Edilson tende a usar a intelectualização como outra estratégia de defesa psíquica, o que pode ajudar a neutralizar o efeito que as emoções produzem. Assim, os processamentos cognitivos constituem o eixo básico de suas operações psicológicas e por meio dessa estratégia os efeitos emocionais podem ser suavizados. No entanto, o paciente pode ficar mais vulnerável a desorganização em situações de sobrecarga emocional, porque esta estratégia ideativa tende a perder eficácia ao aumentar a intensidade dos estímulos afetivos.

Observou-se que o paciente pode atribuir aos objetos percepções internas de elementos disfóricos, ou seja, ele pode adotar um tom mais pessimista e apresentar crenças mais negativas em relação ao seu futuro. Isso pode fazê-lo temer ou desconfiar das ajudas que lhe forem apresentadas, com uma maior inclinação às expectativas menos favoráveis e aos piores augúrios.

Verificou-se que o paciente tende a apresentar deslizos cognitivos moderados, dessa forma, ele pode realizar condensações pouco usuais de vários detalhes cuja presença conjunta é incompatível com a realidade. Isso pode revelar um fracasso na capacidade de discriminação do mesmo e uma forma muito concreta de raciocínio. Ele pode estar realizando integrações irracionais dos dados porque seu pensamento está desorientado e desorganizado.

Mediação

Verificou-se que o paciente tende a não ver as coisas como a maioria das pessoas do seu meio (percepções muito individuais e pouco comuns), o que pode ocorrer por incapacidade ou por reticência a expressar respostas demasiado óbvias. O paciente ao introduzir enfoques pessoais ao estímulo pode converter o produto final em um percepto de menor ajustamento e eficácia. Níveis altos de distorção podem propiciar condutas estranhas, inapropriadas ou desajustadas em relação às exigências reais.



FLÁVIA MARTINS

Psicologia & Neuropsicologia

Processamento da informação

Atualmente o paciente apresentou um baixo nível de motivação e iniciativa, realizando poucos esforços no processamento de dados, o que pode ser decorrente de interferências emocionais. No geral, verificou-se que Sr. Edilson prefere dar respostas simples, econômicas e práticas, com pouco gasto de energia. Algumas vezes verificou-se características de estereotipia e rigidez perceptiva-cognitiva o que pode denotar que o paciente procure caminhos já conhecidos e cômodos na resolução de problemas, arriscando-se pouco. O paciente pode sentir-se inseguro ou incomodado quando tem que tomar decisões e por isso pode preferir focar os problemas de um modo mais individualizado com o intuito de torná-los mais manejáveis. Isso pode acarretar perda das visões em conjunto ou da eficiência prática e consequentemente, uma possível diminuição da qualidade formal ao focar os problemas. Ao fixar-se excessivamente em aspectos pouco importantes do campo de estímulos o paciente pode tender a distorcer a apreensão dos dados, recolhendo pontos de informação acessórios e desprezando dados óbvios.

Sr. Edilson demonstrou que tende a ter um funcionamento cognitivo econômico, minimizando o gasto de energia, o que o leva a atuar sempre abaixo de suas reais possibilidades, ou seja, tende a ser pouco ambicioso ou carente de energia necessária para organizar seus recursos, canalizá-los com propósitos criativos e alcançar fins práticos. O processamento de informação pode estar sendo afetado por uma baixa motivação e diminuição de eficiência. Esta situação pode refletir uma forma de inibição ou retraimento ante a competitividade, o que poderia ser resultado de uma autoimagem negativa.

Traços afetivos

Em relação aos componentes afetivos-emocionais verificou-se que o paciente apresentou muitos traços que são encontrados normalmente entre os diagnosticados de depressão ou transtorno afetivo. Assim, observou-se que Sr. Edilson pode sofrer alterações bruscas no estado de ânimo. Alterações emocionais podem tornar os processamentos cognitivos do paciente mais rígidos ao criarem intensas preocupações.

As emoções tendem a influir nas operações psicológicas do paciente, assim, ele tende a mesclar os sentimentos com seus processos cognitivos enquanto elabora operações de resolução de problemas ou tomada de decisões. Sr. Edilson pode ser mais lábil nas trocas e descargas emocionais, preocupando-se menos em postergar ou modular suas experiências



FLÁVIA MARTINS

Psicologia & Neuropsicologia

afetivas. A afetividade pode ser sua principal forma de obtenção de gratificação, necessitando de uma maior necessidade de proximidade e contato com os demais. Ele pode sentir-se mais solitário e depender mais da presença afetiva de outras pessoas.

Alguns estímulos agem no interior do paciente produzindo sensações de mal-estar e desconforto do tipo emocional, de modo que, mais do que o aumento da tensão interna supõe um aumento de sofrimento e dor psíquicos. A constrição afetiva (calar-se em uma determinada situação por exemplo), a baixa autoestima e o sentimento de solidão podem influir de modo importante na conduta do paciente, mas sobre os quais ele tem pouco controle. Quando os aspectos emocionais aumentam em intensidade e superam a quantidade de recursos organizados com os quais a paciente conta podem provocar uma situação de sobrecarga e predispor a condutas mais impulsivas e a sofrer episódios de desorganização, pois o aumento da irritação interna que ele está sentindo é tão forte que poderia ser potencialmente desorganizada para sua estrutura psíquica.

Percebeu-se que o nível de tensão do paciente tende a aumentar bastante quando ele não consegue exteriorizar seus componentes mais hostis. Sr. Edilson pode estar sendo pouco espontâneo em suas manifestações afetivas e inibindo suas descargas e trocas afetivas. A constrição pode relacionar-se com a tendência do paciente estabelecer relações de dependência, assim, não expressar com fluidez suas emoções pode ser uma forma de evitar ser rejeitado ou abandonado pelos demais. No entanto, a interiorização excessiva pode favorecer a derivação ao corpo dos conflitos psíquicos.

Percebeu-se que o paciente apresenta fortes componentes de desvalorização associados aos processos de introspecção. Assim, ao realizar tarefas de autoexame as impregna de autocrítica negativa o que, por consequência, pode lhe gerar sentimentos de insatisfação, de tristeza e de baixa autoestima.

Relações interpessoais

Sr. Edilson pode buscar sua própria independência, autoafirmação ou apresentar um estilo oposicionista e de rejeição às demandas reais das situações, na atualidade. Isso pode implicar em dificuldade de adaptação social e provocar dificuldades no manejo de seus relacionamentos interpessoais. É importante assinalar que a tendência ao negativismo e à hostilidade, mesmo sendo intensa, não implica necessariamente correlatos na conduta manifesta. Sr. Edilson pode ter mais condutas de resistência passiva do que agressiva.



FLÁVIA MARTINS

Psicologia & Neuropsicologia

O paciente pode ter dificuldades para manejar a complexidade da vida cotidiana e, com isso, pode ter problemas para enfrentar com eficiência as demandas comuns de seu meio social e produzir sentimentos de desvalorização ou baixa autoestima, facilitando a presença de depressões. O paciente pode ficar mais vulnerável às situações de estresse e comportar-se pior quando as circunstâncias externas se tornam complexas ou quando a tensão aumentar, o que pode ser uma consequência do seu desajustamento perceptivo e do seu excessivo controle da expressão afetiva.

Autopercepção

Sr. Edilson pode preocupar-se pouco com suas necessidades ao não se considerar de maneira suficiente ou em colocar em si próprio o foco de sua atenção. Ele pode confiar pouco em seus próprios recursos deixando-se influenciar excessivamente pelos demais ao não conseguir manter seus próprios pontos de vista.

Embora o paciente tenha demonstrado acentuado interesse pelos demais e boa capacidade de empatia, ele parece estar passando por um momento com elevada tendência para o isolamento social e aumento da autocrítica com valor negativo atribuído para si próprio. Dessa forma, ele pode distanciar-se do mundo real para um maior investimento na fantasia quando ele percebe a si mesmo e ao outro. Como consequência ele poderá ter uma percepção mais limitada e distorcida a respeito das pessoas ao seu redor, parecendo alheio e retraído. Essas distorções na auto e alo-percepção podem exercer um efeito negativo nas tomadas de decisão do indivíduo, nas soluções que ele dê aos problemas e, principalmente, em suas relações interpessoais.

O paciente demonstrou aumento da preocupação com o próprio corpo, o que pode relacionar-se com alterações na autoimagem, mudanças fisiológicas ou enfermidade orgânica.

Controles

Sr. Edilson demonstrou que possui poucos recursos internos para enfrentar seus disparadores internos de tensão. Ele pode estar sobrecarregado ou recebendo mais estimulação irritativa maior do que sua capacidade de gerar respostas destinadas a enfrentar e recuperar a homeostase. Esta sobrecarga pode predispor-lo a um funcionamento cognitivo ineficaz, às vezes, porque não consegue processar a informação adequadamente.



FLÁVIA MARTINS

Psicologia & Neuropsicologia

Sr. Edilson pode apresentar dificuldades ante situações novas e geralmente funcionará melhor em meios rotineiros e previsíveis. Quanto mais nova e complexa for a realidade que enfrente, mais confuso se pode sentir, produzindo condutas ineficazes.

Acredita-se que o paciente se sinta pressionado por uma tensão interna maior do que ele pode lidar, e como resultado suas respostas são insuficientes, pouco eficazes e por isso pode se desorganizar abertamente se as circunstâncias externas se complicarem. As decisões precipitadas, os impulsos emocionais ou a ineficácia generalizada de conduta são usuais nele, pois sofre de uma vulnerabilidade crônica à impulsividade ideativa ou afetiva.

Conclusão:

O paciente apresentou um excelente desenvolvimento cognitivo, mostrando-se superior a faixa normativa em relação ao QI total, QI verbal e QI de execução. Podem existir déficits de linguagem e percepção visual associados com alterações sensoriais (auditivas e visuais). Também foram observados déficits atencionais (WAIS-III, NEUPSILIN, MEEM, Teste Stroop) e alterações em memória operacional (WISC-III), memória episódica tardia (NEUPSILIN, MEEM), memória imediata visual (Figuras Complexas de REY e NEUPSILIN). O paciente apresentou boa capacidade de funções executivas (teste trilhas, FAS), práxis, raciocínio verbal e raciocínio fluído (WAIS-III).

Os déficits cognitivos podem relacionar-se com desorganização do pensamento associado com alterações afetivo-emocionais, processo de envelhecimento, alterações sensoriais ou organicidade. O paciente deverá ser melhor avaliado clinicamente e em conjunto com resultados de exame de ressonância magnética funcional. Para melhor compreensão do caso sugere-se reavaliação no prazo de oito meses após o início do tratamento.



FLÁVIA MARTINS

Psicologia & Neuropsicologia

Recomendações:

Avaliação clínica de funções auditivas e visuais.

Continuidade do acompanhamento neurológico com investigação de quadro de depressão associado ao processo de envelhecimento e/ou processo de organicidade.

Acompanhamento psicológico do quadro emocional e interferências do curso do pensamento.

Estimulação cognitiva para mecanismos atencionais, memória operacional e linguagem.

Reavaliação neuropsicológica no prazo estimado de oito meses.

O sigilo ético profissional das informações contidas nesse relatório deverá ser preservado pela equipe multiprofissional, de acordo com o artigo 6º, do Código de Ética Profissional dos Psicólogos – "compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as recebeu de preservar o sigilo".

Brasília, 12 de novembro de 2015.

Dra Flávia Martins da Silva

CRP 01/9526

Psicóloga

Bacharel em Química

Especialista em Neuropsicologia - CRP

Me. Neurociências do Comportamento e Cognição - UnB

PhD. Neurociências do Comportamento e Cognição - UnB